Anexo Único

Pautas de intervención para las Policías de la provincia de Buenos Aires en materia de Salud Mental

Introducción

Las recomendaciones presentes tienen como objetivo brindar herramientas básicas para la actuación policial ante urgencias de salud mental, ya sea de personas con padecimiento mental, estado de intoxicación y/o consumo problemático de sustancias.

El fin de esta intervención será:

Reducir riesgos y preservar la seguridad física y psíquica de las personas
Evitar un escalamiento de la agresividad
Solicitar inmediata asistencia de equipos de salud y/o generar condiciones favorables para la intervención de dichos equipos
Preservar la situación de seguridad pública
Prevenir y hacer cesar hechos de violencia y/o delitos

Estas pautas se enmarcan en lo prescripto por la **Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657** (Derecho a la protección de la salud mental), su Decreto Reglamentario N° 603/2013 y la Ley Provincial N° 14.580.

La Ley 26.657 de Salud Mental, en sus **artículos 20 a 25,** detalla la información relativa a las **internaciones involuntarias**, es decir, aquellas que se realizan sin el consentimiento de la persona. En los artículos mencionados el criterio que habilita a los equipos de salud a indicar una internación involuntaria es el **riesgo cierto e inminente,** para sí y/o para terceros, determinado en relación a la persona evaluada.

El Decreto N° 603/2013 que reglamenta la Ley Nacional de Salud Mental dice en su artículo 20: “Entiéndase por riesgo cierto e inminente a aquella contingencia o proximidad de un daño que ya es conocido como verdadero, seguro e indubitable que amenace o cause perjuicio a la vida o integridad física de la persona o de terceros”.

La intervención policial tendrá lugar toda vez que los equipos de salud no hayan alcanzado una resolución a la crisis de salud mental, aunque en muchas ocasiones es el efectivo policial el primero en llegar al lugar, debiendo tener en consideración que se requiera el pedido de asistencia inmediata al personal de salud, los criterios de intervención, su techo operativo (entendido como el límite de la capacidad operativa) y en función de éste, el consecuente pedido de apoyo a negociadores y grupos tácticos.

En toda intervención policial que implique el traslado a una dependencia policial, donde existan sujetos atravesando una crisis de salud mental, sea cual fuese el origen de la crisis, se deberá trasladar a la institución de salud que se determine previamente. Siempre en la medida de lo posible y tratándose de una persona en crisis por salud mental, se debe hacer el traslado en un móvil sanitario, eventualmente si el caso lo requiere con acompañamiento de personal policial. Por tal motivo las actuaciones se harán en el lugar del hecho hasta tanto se haga presente el equipo de salud convocado para las evaluaciones y traslados correspondientes. Se labrarán actas tendientes a documentar lo actuado identificando también al personal de salud que asista al lugar.

Las interacciones de las Fuerzas Policiales con personas con presunto padecimiento mental y/o en situación de consumo de sustancias en el marco de las intervenciones de proximidad

Desde el **modelo de uso racional de la fuerza** resulta crucial comprender la acción policial en términos de interacciones. El/la funcionario/a policial interviene ante un otro que denominaremos **sujeto activo**.

El sujeto activo puede definirse como toda persona que “motiva” el accionar policial.

Entendemos que esta motivación a la acción no solo proviene de personas en conflicto con la ley, sino también de aquellas personas que interactúan con la policía a diario, desde un pedido de orientación o asistencia, hasta un enfrentamiento armado, ya que toda interacción (por mínima que sea) que un sujeto tenga para con el/la funcionario/a policial lo convierte en **sujeto activo**.

La introducción de este término es fundamental para evitar encasillar la función e intervenciones policiales como mera aplicación de la ley penal. Sabemos que las Fuerzas de Seguridad tienen un rol mucho más abarcativo. Citando un ejemplo, una intervención de asistencia en un parto en la vía pública nada tiene que ver con personas violando la ley, sin embargo, este tipo de actuaciones son muy comunes y más frecuentes de lo que parece.

El personal policial va a determinar su actuación en base al comportamiento que tenga el sujeto activo. Si el mismo se encuentra tranquilo, colaborador y no representa un riesgo (para sí mismo, para el personal policial o para terceros), ni manifiesta intenciones de confrontación con el policía, con la sola presencia y comunicación de este último será suficiente para solucionar el conflicto o intervenir en el sentido que resulte necesario. Sin embargo, en el caso que el policía elevara el nivel de fuerza,

mediante una comunicación inadecuada o intentando aplicar alguna técnica sobre el sujeto, la respuesta del mismo irá en igual sentido, precipitando una escalada en los niveles de conflictividad e incrementando a la vez los niveles de uso de la fuerza por parte del efectivo.

Toda intervención policial debe darse en el marco del modelo de uso racional de la fuerza.

Resulta importante tener siempre presente que los procedimientos y técnicas comprendidos por estos lineamientos son ejecutados por funcionarios/as encargados de hacer cumplir la ley, quienes se encuentran habilitados a intervenir en tanto profesionales de la seguridad y deben **ajustar su proceder al marco normativo y doctrinario** que, en el contexto de un Estado de derecho, legitima y respalda su acción.

La policía tiene la función de garantizar el cumplimiento de la ley en nuestra sociedad. Sin ella, podríamos encontrarnos ante escenarios y situaciones donde se impongan los intereses arbitrarios de un determinado grupo por sobre el conjunto social. Sin los funcionarios/as de las Fuerzas Policiales y de Seguridad no se podría ejecutar la ley de manera justa e imparcial. Para ello, la policía cuenta con la autoridad para hacer uso de la fuerza de manera legítima. De hecho, debemos decir que, aunque suene redundante, **las Fuerzas Policiales y de Seguridad son fuerza**. La mera presencia policial ejerce un efecto disuasivo para quienes tengan intenciones de cometer un acto contrario a la ley.

Existe una proyección simbólica de la fuerza, el sujeto que observa al policía sabe que ese funcionario está habilitado a utilizarla y que cuenta con la legitimidad para ello. Dicha legitimidad tiene su fundamento en un Estado de derecho, definido en base a que toda su actividad se encuentra subsumida a lo establecido por la Constitución Nacional y los mecanismos que la misma establezca para la sanción de leyes y otras normas. De ello se deriva que el daño que generan los actos corruptos, arbitrarios o discrecionales por parte de funcionarios/as policiales, entrañan un grave perjuicio para la estabilidad de la vida en sociedad, ya que significan un cercenamiento del libre goce de derechos por parte de quienes deben, justamente, encargarse de protegerlos y garantizarlos.

El ejercicio del poder de hacer cumplir la ley implica entonces una especial atención y regulación por parte de los Estados.

En este contexto, debemos tener presentes los **Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego**, aprobados por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Dentro del marco normativo aplicable a la función de la Policía de la provincia de Buenos Aires, dichos principios se encuentran expresados en la Ley 13.482, Título II “Principios y procedimientos básicos de actuación”.

El siguiente cuadro representa una síntesis y facilitará la interpretación de los textos normativos:

PRINCIPIO	DESCRIPCIÓN
LEGALIDAD	**¿Estoy habilitado para usar la fuerza?** El uso de la fuerza solo está autorizado cuando el objetivo que se pretende alcanzar y el modo en que se utiliza ese recurso se encuentran respaldados por normas jurídicas que así lo autorizan. En relación a ello, el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Policiales y de Seguridad tiene que adecuarse a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, así como a los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.
OPORTUNIDAD	**¿Es necesario usar la fuerza?** Cuando todos los demás medios legítimos para alcanzar ese objetivo resulten ineficaces y el uso de la fuerza no acarree consecuencias más lesivas que aquellas que se producirían en caso de no recurrir a ella. En este sentido, el uso de la fuerza es siempre un medio para la consecución de un fin policial legítimo. Por tanto, recurrir a él requiere la evaluación desde un punto de vista tanto táctico, como ético. La oportunidad de usar la fuerza por parte de la policía resultará de la evaluación del riesgo que presente la situación, conforme las circunstancias que objetivamente produzcan o pudieran producir un agravamiento o desescalamiento del conflicto y la violencia.
PROPORCIONALIDAD Y MODERACIÓN	**¿Cuánta fuerza debo utilizar?** El nivel de fuerza aplicado debe ser proporcional a la agresión recibida, la gravedad de la amenaza y los riesgos objetivos que de ella surjan, procurándose evitar daños innecesarios (moderación). Así, el grado de fuerza aplicado deberá ser evaluado por el personal en relación a la gravedad del delito y al objetivo que se persiga salvaguardar.

RESPONSABILIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS	**¿Cuáles son las razones que fundamentan mi actuación?** El personal debe asumir las responsabilidades de su accionar y rendir cuentas por las acciones efectuadas. Quien utiliza la fuerza, sus superiores y, en última instancia el Estado, deben rendir cuentas por esa acción y responder por las consecuencias que acarree su uso.

Entendemos entonces al **accionar policial como una interacción dinámica**, donde el policía evalúa constantemente y planifica una respuesta en función de la conducta de un sujeto. Para actuación ante situaciones de conflicto el personal aplicará el protocolo L.A.C.E.R.:

L ocalizar el espacio físico del conflicto

A islar a los intervinientes y/o personas involucradas

C ontener a las partes directas y/o terceros

E valuar mediante la información obtenida en el lugar

R esponder intentando resolver la situación, siempre acorde al marco legal

El objetivo del funcionario/a policial debe ser siempre el **resguardo de la vida y la integridad física, propia y la de terceros**. Por ello se orientará a desescalar los niveles de conflictividad y utilizar la fuerza mínima indispensable, entendiendo al uso de la fuerza de manera gradual y escalonada, desde la mera presencia policial, la comunicación, la aplicación de técnicas blandas o técnicas duras, hasta el uso de la fuerza potencialmente letal. A su vez, resulta importante comprender que la aplicación de un nivel de fuerza implica la posibilidad de **desescalar** una vez que la situación se encuentra controlada.

Esta **actividad constante de evaluación** que realizan los/as funcionarios/as encargados/as de hacer cumplir la ley, es fundamental a la hora de intervenir en determinadas problemáticas que requieren de una mirada y abordaje especial. **La forma en la que se comprende determina la forma en que se interviene**.

En ese marco, existen determinados contextos de intervención que requieren una mirada integral y aportes de diversos campos de conocimiento. Las llamadas **intervenciones de proximidad** se caracterizan por presentar esta complejidad, a la vez que son situaciones recurrentes que los funcionarios policiales deben resolver en su labor profesional cotidiana. Dentro de las intervenciones de proximidad se encuentran, por ejemplo, el abordaje de situaciones que involucren a niños, niñas y

adolescentes, los casos de violencia de género o las intervenciones que involucren a personas con presunto padecimiento mental y/o que se encuentren en situación de consumo problemático de sustancias.

Es importante para los/as funcionarios/as encargados de hacer cumplir la ley, determinar el punto de partida desde el cual van situarse al momento de intervenir. La percepción de la conducta de ese otro puede estar atravesada por los propios prejuicios, la historia de vida, la formación que ha recibido, entre otros factores. Por todo esto se torna fundamental abordar las temáticas que implican las mencionadas intervenciones de proximidad, desde las distintas dimensiones que constituyen a las problemáticas y desde los diferentes saberes disciplinarios que aportan a su resolución.

En lo que atañe a las intervenciones con personas con presunto padecimiento mental y/o que se encuentran en situación de consumo problemático de sustancias, el enfoque suele centrarse en la aplicación de la Ley 23.737 de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes, con menor consideración del enfoque de salud que dichas situaciones requieren, el rol de asistencia y de cuidado de las Fuerzas de Seguridad, además de las normas específicas que deban ser de aplicación ante determinados casos.

¿Es el consumo problemático un problema social?

Entendemos la **problemática del consumo como un síntoma social** que está íntimamente relacionado con el malestar en el vivir que atraviesa a todos los sectores sociales. Para comprender el fenómeno es necesario tener presente el modelo económico y cultural de la época.

Es un problema que involucra a todos los sectores sociales. La práctica del consumo no se esconde, se muestra. Alguien que por causa de la dependencia se encuentra en estados de deterioro físico y psíquico, antes dejó de comer, de jugar, de ir a la escuela, de tener proyectos. Provoca ruptura de lazos o vínculos habituales.

¿Es el consumo problemático un problema de salud?

La Ley Nacional de Salud Mental establece en su Artículo 4º.- “Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud“.

Al abordar el tema de consumos problemáticos de sustancias desde la perspectiva de la salud, es central comprender el concepto de enfermedad en un sentido amplio ya que el consumo afecta al sujeto en el cuerpo, o sea en lo orgánico, pero también psicológicamente y en su relación con los

demás. Consumir compulsivamente y en cantidad es riesgoso y fatídico. Se establecen diferentes cuadros tóxicos:

- Pérdida de conciencia.
- Cuadros de intoxicación.
- Excitación o inhibición psicomotriz.
- Comportamientos autodestructivos.

En la atención de las crisis se debe diferenciar la **urgencia** de la **emergencia**:

- **Emergencia**: riesgo vital, actuación inmediata de primeros auxilios.
- **Urgencia**: riesgo potencial.

En situaciones de crisis se requiere inmediatamente la intervención del Sistema Sanitario.

¿A quiénes acudir?

El Sistema Sanitario es quien debe atender la urgencia en salud mental.

- SAME (107)
- Guardias Hospitalarias
- Equipos de Atención Primaria de Salud

- ¿Es el consumo problemático un problema de seguridad?

El consumo en sí mismo no constituye una práctica delictiva, y solo representa un problema de seguridad cuando se realiza en el **espacio público e implica la comisión de un delito o, sin llegar a ello, altera la convivencia**, es decir, se generan situaciones de conflicto que no pueden resolverse por la propia dinámica social y requieren de la intervención del personal policial. Por lo tanto es central pensar prácticas innovadoras en el restablecimiento del orden en el espacio público, sobre todo entendiendo que en los barrios se entremezcla lo público y lo privado. Por un lado, se requiere la intervención de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en la negociación y resolución de

conflictos para evitar el incremento de la conflictividad[1]. Por el otro, es competencia del área de Seguridad intervenir cuando el consumo constituye un riesgo para sí mismo, o para terceros.

> El Artículo 20 de la Ley Nacional de Salud Mental establece: "(…). No se incluyen los riesgos derivados de actitudes o conductas que no estén condicionadas por un padecimiento mental. Las Fuerzas de Seguridad que tomasen contacto con una situación de riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros por presunto padecimiento mental, deberán intervenir procurando evitar daños, dando parte inmediatamente y colaborando con el sistema de emergencias sanitarias que corresponda. Aún en el marco de una internación involuntaria, deberá procurarse que la persona participe de la decisión que se tome en relación a su tratamiento".

Pautas de intervención policial ante situaciones de consumo problemático de sustancias y/o presunto padecimiento mental

¿Cuál es la finalidad u objetivo de la actuación de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad cuando intervienen en esta problemática?

Desde el rol de los/as funcionarios/as de las Fuerzas Policiales y de Seguridad es importante tener claro que las situaciones en materia de salud mental y/o abuso de drogas son situaciones difíciles, no sólo por lo que son en sí mismas para la persona y su entorno, sino para quién está allí interviniendo.

¿Qué nos pasa como efectivo policial con alguien que además de desafiar la autoridad que representamos, está consumiendo delante de nosotros? Es central para cada efectivo tomar internamente distancia, y buscar ser neutrales de nuestras propias ideas sobre "la locura", "el vicio" o "la adicción", nuestros prejuicios, y los sentimientos que la actitud de los jóvenes nos provoca a cada uno/a. La **actuación** debe siempre orientarse por un **criterio profesional**. Pensar esto va a definir cuánto mejor o no se usen las herramientas para intervenir. Muchas veces la edad de quién consume es igual a la de los/as funcionarios/as. Es importante recordar que el rol es más amplio que la edad y que la responsabilidad de ese joven y del funcionario/a son diferentes. Si se puede pensar esto, vamos a poder intervenir, de lo contrario sólo usaremos la fuerza de coerción como el único recurso.

La finalidad de su actuación es preservar la seguridad de las personas y facilitar las condiciones para el acceso de los servicios de salud y sociales.

- **¿Cómo se debe intervenir?**

[1] Llamamos escalada al modo en que el conflicto crece y aumenta, mientras que desescalamiento es la etapa en la que el conflicto se reduce paulatinamente. Lo peligroso de la escalada es que, una vez comenzada, resulta difícil revertir su proceso

Para intervenir en situaciones de presunto padecimiento mental y/o consumo problemático de sustancias se debe:

1. Determinar el nivel de riesgo.
2. Garantizar una contención inicial de la situación.
3. Considerar estrategias de intervención.

Posibles **comportamientos y estrategias para su abordaje**:

1. **Determinar el nivel de riesgo**

La evaluación inicial es una breve valoración del riesgo a la seguridad de daño inminente para el sujeto:

a. **Evaluación inicial de la situación**: consiste en diferenciar entre una conducta problemática (desnudarse, insultar al personal policial, etc.) y una conducta riesgosa.

b. **Evaluación sobre la claridad de conciencia**: se evaluará la claridad de conciencia con preguntas personales y témporo-espaciales como: nombre, fecha, ubicación, etc.

Estar atento al entorno para obtener información de la persona asistida: padecimientos mentales, problemas vitales que podría padecer, sustancias que pudiera haber ingerido o si hubo episodios anteriores.

Algunos indicadores según la clase de sustancia utilizada:

► **Depresores**: pérdida o disminución grave de la conciencia, incapacidad para hablar, rostro pálido, vómitos, labios y/o uñas azules, latidos y pulso débiles, respiración lenta, etc.

► **Estimulantes**: pérdida de la conciencia repentina, temblores, convulsiones, paro cardíaco y accidentes cerebro-vasculares (ACV), etc.

2. **Contención inicial de la situación**

Son las primeras estrategias verbales o comunicacionales de contención.

Algunas orientaciones que pueden ser de aplicación en esta instancia[2]:

[2] Será determinante la evaluación del personal policial al momento de la intervención. Cada situación tiene características particulares, debe primar siempre el criterio profesional.

- ► No mostrarse hiperactivo.
- ► Mantener un estilo calmo.
- ► Hablar en forma clara y respetuosa.
- ► No intentar ser gracioso.
- ► No utilizar el sarcasmo.
- ► No entrar en luchas de poder.
- ► No dar consejos.
- ► Evitar el incremento de la conflictividad.
- ► Durante la contención no ostentar el arma.
- ► En función de la evaluación constante del techo operativo, solicitar apoyo de ser necesario.
- ► Aislar la situación y solicitar que se retiren las personas ajenas a la escena (exceptuando testigos que puedan ser de utilidad para aportar información o colaborar con la intervención).
- ► Solicitar dos testigos que brinden información del hecho.
- ► Controlar la distancia física, procurar pararse en el ángulo de 45 grados respecto de la persona afectada y NO darle la espalda.
- ► Rendir informes a las agencias intervinientes así como al sujeto activo.
- ► Comunicar la información obtenida al personal médico.
- ► Evitar en todo momento el incremento de la conflictividad.

3. Estrategias de intervención según el estado del sujeto activo

a. Padecimiento NO violento

b. Padecimiento violento

c. Pérdida de conciencia

d. Casos especiales

a. Personas con padecimiento NO violento

Aquí nos encontramos con un sujeto que, por ejemplo, se encuentra consumiendo en la vía pública, con un andar desorientado. La intervención policial será la diferencia entre que empeore su situación o ser un derivador eficaz hacia otro espacio de ayuda.

Para ello, la **contención verbal** es fundamental. Se entablará un diálogo con la persona, con el fin de recabar la mayor cantidad de datos posibles, en especial, los que tengan que ver con la sustancia que está consumiendo. Esto permitirá brindarle mayor información al sistema de salud, al cual se debe convocar de forma inmediata. Para ello, el/la funcionario/a utilizará un lenguaje simple y claro, evitando tecnicismos, tendientes a explicar los pasos a seguir. Buscará promover un espacio seguro para la persona. Se deberá **convocar a un vínculo o referencia de confianza para la persona**, si esta pudiera indicarlo.

De acuerdo a lo expresado en el Artículo 30 de la Ley Nacional de Salud Mental: *"Las derivaciones para tratamientos ambulatorios o de internación que se realicen fuera del ámbito comunitario donde vive la persona sólo corresponden si se realizan a lugares donde la misma cuenta con mayor apoyo y contención social o familiar. Los traslados deben efectuarse con acompañante del entorno familiar o afectivo de la persona…"*

Resumiendo…

- Contención verbal, obtención de datos.
- Solicitar asistencia inmediata del equipo de salud.
- Lenguaje simple para explicar las acciones que se harán.
- Proveer un ambiente seguro y orientación de manera constante.
- Procurar que la persona acceda a la asistencia médica.
- Solicitar información a terceros.

b. Personas con padecimiento violento

En tanto que los comportamientos autolesivos suponen graves riesgos para la salud y la vida de las personas, **la prioridad es resguardar su integridad**. En estos contextos de emergencia se debe:

► Resguardar la seguridad del sujeto activo, del personal de la Fuerza y/o terceros.

► Solicitar asistencia inmediata del equipo de salud.

► Observación rigurosa de la persona a fin de detectar posibles comportamientos de riesgo (por ejemplo, que la persona intente autolesionarse con una botella o cualquier elemento cortante)

► Asegurarse que la persona no escape.

► Retirarle armas, drogas o medicamentos.

► En caso de ser **estrictamente** necesario (riesgo cierto e inminente), realizar **restricción física**. Como estamos en presencia de una persona con presunto padecimiento mental y en el marco de la Ley de Salud Mental, esta restricción física se realizará con la mayor cantidad de efectivos posibles, tendientes siempre a proteger la integridad física del sujeto, entendiendo que esta

situación está siendo potenciada por el consumo de sustancias y no por la propia voluntad de la persona.

c. Personas con pérdida de conciencia

Imaginemos que, debido al llamado al 911 de un vecino, acude el personal policial a una intervención y se encuentra con un sujeto tendido en la vía pública. Al arribo, es fundamental que el/la funcionario/a convoque al **servicio de salud**.

Considerando que el sujeto se encuentra inconsciente, será fundamental buscar testigos o personas que puedan facilitar información acerca de lo que ha acontecido. También, observar el lugar en busca de indicios que indiquen qué tipo de sustancia ha consumido.

Hasta el arribo de la ambulancia, podrán realizar primeros auxilios en caso de ser necesario.

Resumiendo…

- Solicitar asistencia inmediata del equipo de salud.
- Indagación sobre sustancias ingeridas.
- Recabar datos de terceras personas.
- Observar posibles indicadores de intoxicación.

d. Casos especiales

1. *Niños, niñas y adolescentes*

En caso de que se trate de niños, niñas o adolescentes, la intervención deberá asegurar la asistencia del órgano de protección de derechos competente (Subsecretaría de Niños, Niñas y Adolescentes - Servicio Local - Servicio Zonal) quien será el responsable de continuar con las intervenciones. Hasta su arribo, la contención verbal es fundamental, así como el acompañamiento y la asistencia.

Ante la duda, se considerará siempre al sujeto como menor de edad.

Frente a situaciones en que las que se encuentren en riesgo niños, niñas o adolescentes se deberá:

- Requerir la asistencia del equipo de salud.
- Contener, acompañar, asistir y brindar cuidados básicos.

2. *Respeto de la privacidad e integridad física y sexual de las personas*

Las personas que se encuentran en situación de riesgo deben ser tratadas con absoluto respeto de sus derechos y garantías constitucionales, sin discriminación por la condición de migrante, extranjero, identidad de género o cualquier otro motivo que refiera a la singularidad de la persona o al colectivo al que pertenece.

En los casos de personas sordas o hipoacúsicas o para el caso de no compartir el idioma, garantizar en lo posible una comunicación entre el interventor y el sujeto activo a través de intérpretes (vecinos/as, personas del círculo familiar del sujeto que pueda facilitar la comunicación). Muchas veces, la no contestación por parte de las personas es tomada como un no acatamiento a las órdenes. Sin embargo, se suele dejar de lado factores como los descriptos más arriba como la causa de esa falta de respuestas.

Todo traslado de una persona con padecimiento mental deberá realizarse según las indicaciones provistas por el personal de salud competente. Previo a cualquier traslado a dependencia policial deberá procurarse contar con un aval médico que indique que la crisis de salud ha cesado y que su traslado y alojamiento no acarreará mayor riesgo.

Bibliografía

► Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 (Derecho a la protección de la salud mental).

► Decreto Reglamentario N° 603/2013.

► Ley Provincial N° 14.580.

► Manual de Capacitación en el Uso Racional de la Fuerza, Ministerio de Seguridad (2015).

► Orientaciones para la Enseñanza del Uso Racional de la Fuerza, Ministerio de Seguridad (2015).

► Resolución N° 506/2013 Ministerio de Seguridad de la Nación.

G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2022 - Año del bicentenario del Banco de la Provincia de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2022-13803700-GDEBA-SSFYDPMSGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Viernes 6 de Mayo de 2022

Referencia: EX-2022-02281506-GDEBA-DDPRYMGEMSGP

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS, ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511
Date: 2022.05.06 16:11:30 -03'00'

Eduardo Javier Alonso
Subsecretario
Subsecretaría de Formación y Desarrollo Profesional
Ministerio de Seguridad

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS, ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511
Date: 2022.05.06 16:11:31 -03'00'